# B3 • PARAMÈTRES VITAUX

## 1 PRINCIPES



- **Homéostasie :** maintien de l'équilibre interne.
- **Évaluer ensemble** valeurs, symptômes, évolution et état habituel.
- Tachycardie/tachypnée peuvent précéder une chute de PA : une PA normale n'exclut pas un choc.
- **Mesurer au repos** ; matériel adapté ; tracer heure, unités, site et contexte ; contrôler puis alerter sans retarder l'urgence.

## 2 TEMPÉRATURE




- **Repère :** 36,5–37,5 °C selon site/horaire ; fièvre ≥ 38 °C ; hypothermie < 35 °C.
- **Fièvre :** consigne thermique augmentée ; hyperthermie : excès de chaleur sans hausse de consigne.
- **Production :** métabolisme, muscles/frissons ; **conservation :** vasoconstriction.
- **Pertes :** rayonnement, conduction, convection, évaporation.
- **Variations :** rythme circadien, cycle, effort ; toujours noter le site.
- **Frissons** → plateau chaud → défervescence avec sueurs ; surveiller hydratation.
- **Coup de chaleur :** souvent ≥ 40 °C + signes neurologiques = urgence ; alerter et refroidir ; antipyrétiques inefficaces. **Hypothermie :** réchauffer selon protocole.

## 3 RESPIRATION



- **Adulte au repos :** FR 12–20/min ; compter 60 s.
- **Observer** amplitude, régularité, symétrie, bruits.
- **Tachypnée :** rapide ; **bradypnée :** lente ; **apnée :** arrêt.
- **Dyspnée :** gêne ; **orthopnée :** aggravée couché.
- **Alerte :** tirage, difficulté à parler, cyanose, agitation, épuisement.

## 4 SpO₂




- **Adulte sain en air ambiant : 95–100 %.**
- **Cibles du cours sous $O_2$ : 94–98 %** ; risque d'**hypercapnie** : 88–92 % sur prescription/protocole.
- **Vérifier signal,** doigt chaud, mouvements, vernis/hypoperfusion.
- Une **$SpO_2$** normale n'exclut pas une détresse ni une hypercapnie.
- **Tracer** air ambiant ou **$O_2$** : dispositif et débit.

## 5 POULS / FC



- **Adulte au repos :** 60–100 batt/min ; bradycardie < 60 ; tachycardie > 100.
- **Index/majeur,** pas le pouce ; 60 s si irrégulier.
- **Fréquence,** rythme, amplitude, symétrie.
- **Radial :** périphérique ; **carotidien/fémoral :** centraux.
- **Valeur automatique :** vérifier cliniquement si doute.

## 6 PRESSION ARTÉRIELLE






- **mmHg : PAS** = systole ; **PAD** = diastole.
- **Repère optimal :** < 120/80 ; **HTA au cabinet :** ≥ 140 et/ou ≥ 90, mesures répétées.
- **Alerte :** PAS < 90 et/ou PAM < 65, surtout avec malaise, marbrures, confusion, oligurie.
- **Brassard adapté,** repos, bras au niveau du cœur.
- Éviter bras avec fistule ; autres contraintes (perfusion, plaie, lymphœdème/curage) : choisir site selon situation/protocole.

## 7 DIURÈSE • BU • GLYCÉMIE








- **Diurèse adulte :** ≈ 0,5–1 mL/kg/h ; souvent 1–2 L/24 h selon apports.
- **Oligurie :** < 0,5 mL/kg/h persistante ; **anurie :** < 100 mL/24 h ; **polyurie :** > 3 L/24 h.
- **Rétention ≠ anurie :** vessie pleine, évaluer.
- **BU :** leucocytes/nitrites, sang, protéines, glucose/cétones ; orientation, pas diagnostic isolé ; respecter lecture.
- **Glycémie à jeun :** généralement 0,70–1,09 g/L ; **hypo** < 0,70 ; < 0,54 : importante.
- **Diabète :** glycémie veineuse à jeun ≥ 1,26 g/L, à confirmer.
- **Hypoglycémie :** protocole ; rien par bouche si conscience/déglutition altérée.

## 8 ENFANT & ALERTES



- **Normes FR/FC selon âge :** ne pas appliquer celles de l'adulte.
- **Nouveau-né :** FR 40–60/min ; FC ≈ 90–180/min (repères du cours).
- **Hypotension pédiatrique,** PAS :
  - nouveau-né < 60
  - 1–12 mois < 70
  - 1–10 ans < 70 + 2 × âge
  - > 10 ans < 90 mmHg.
- **Fièvre avant 3 mois :** avis médical urgent.
- **Médicaments :** prescription/protocole, dose en mg/kg ; ne pas transposer dose adulte.
- **Détresse respiratoire, trouble de conscience, choc :** alerte immédiate et protocole d'urgence.

**Synthèse des notes B3** • Repères à adapter au patient et au protocole • UE non précisée